MAPA DE CONSULTA RÁPIDA · PLANTÃO

Ventilação Não Invasiva (VNI)

Interfaces, instalação à beira do leito e sinais de alerta

Antes de Instalar — PRÉ-REQUISITOS

- Objetivo é **ventilar**: variar o volume, encher os alvéolos e eliminar o CO2. Só O2, mesmo em litragem alta, pode não resolver.
- Paciente acordado, responsivo, cooperativo e entendendo a terapia.
- Exceção: sonolento por retenção de CO2 (carbonarcose), em que a VNI pode evitar a intubação.
- Sentado, cabeceira elevada.
- Checar radiografia de tórax do dia e gasometria, se houver. Pneumotórax: **não realizar VNI**.

Quando Retirar — ALERTA

- **Vômito, enjoo ou ânsia**: o mais emergencial (risco de broncoaspiração).
- **Rebaixamento do nível de consciência**: não protege mais a via aérea. Retirar e chamar a equipe.
- **Hipotensão grave/choque**: uma queda leve da PA é esperada (menos retorno venoso).
- **Agitação/ansiedade**: retirar, discutir com a equipe médica uma medicação calmante (não sedativa) e retomar.
- Pode tirar sem medo: é só soltar o velcro.

Instalação Passo a Passo — ALGORITMO PRINCIPAL

1. Escolher a máscara conforme o estado do paciente e o aparelho (ventilador ou BiPAP).
2. Explicar ao paciente: ar pressurizado, “ventinho” no rosto, o aparelho ajuda a respirar.
3. Iniciar com pressões bem baixas, sem se preocupar com o volume.
4. Encostar e segurar a máscara no rosto, **sem fixar**, até ele se acostumar.
5. Ajustar a máscara e depois os parâmetros; o tempo de terapia conta a partir daí.
6. Subir a pressão até um volume próximo do calculado para o peso predito, com conforto.
7. Fixador só com o paciente calmo, cooperativo e aceitando bem (mais fácil com ajuda).
8. Reavaliar: melhora em ~15 min = bem instalada. Sem melhora em 1 h, reavaliar (possível intubação).

Modos e Oxigênio — PARÂMETROS

- **CPAP**: apneia do sono e edema agudo de pulmão/congestão, com pressões em torno de 10 cmH_2O.
- **BiPAP**: feito tanto no ventilador quanto no aparelho de BiPAP. Quanto maior o IPAP, maior o volume (na teoria).
- Volume-alvo individual, de acordo com o peso predito. Começar baixo e ir aumentando.
- Ventilador: fornece O2 pela rede de gases.
- BiPAP: **não fornece O2**. Enriquecer com fluxômetro + umidificador e a extensão de O2 na máscara, no circuito ou em um filtro umidificador.

Interfaces e Circuitos — ESCOLHA

- **Ventilador** (circuito duplo): máscara com joelho fechado, sem furinho e sem escape.
- **BiPAP** (ramo único): máscara com saída exalatória (válvula de silicone ou conector com furinho), sempre aberta.
- **Nasal**: só se o paciente mantém a boca fechada. Confortável para uso prolongado e só no BiPAP.
- **Oronasal / facial total**: quando não mantém a boca fechada ou tem nível de consciência rebaixado.
- **Facial total**: a mais usada. Distribui melhor a pressão, sendo melhor para períodos longos, mas claustrofóbicos podem estranhar.
- **Traqueostomizado**: BiPAP com válvula exalatória na traqueia do circuito.

Nunca Faça — PROIBIÇÕES

- Nunca vedar com esparadrapo o escape do BiPAP. Ele é esperado, porque é por ali que o CO2 sai.
- Nunca cobrir a válvula exalatória (nem com o lençol). Deixá-la sempre do lado de fora.
- Nunca fazer VNI com o paciente deitado a 0°.
- Nunca fazer VNI com pneumotórax: há risco de aumentá-lo e piorar o quadro.
- Nunca manter a VNI com vômito ou ânsia de vômito.

Material de apoio para consulta rápida durante o plantão · baseado na aula sobre ventilação não invasiva

Material produzido pela fisioterapeuta Nathalia Ramos